ICS **.***.**
C**

团体标准

T/CACM ****—20**

结直肠癌疼痛中西医结合诊疗指南

Guideline for diagnosis and treatment of colorectal cancer pain with integrated Chinese and Western Medicine

（文件类型：草案）

20**-**-**发布 20**-**-**实施

中华中医药学会发布

目　录

前言 3
引言 4
1　范围 5
2　规范性引用文件 5
3　术语和定义 5
4　结直肠癌疼痛的流行病学 5
5　结直肠癌疼痛的发病机制和病因病机 5
6　结直肠癌疼痛的诊断 6
7　结直肠癌疼痛的中西医治疗 7
8　推荐意见及证据描述 13
资料性附录 15
参考文献 21

前　言

本指南按照GB/T1.1—2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》规定的规则起草。

本指南由中华中医药学会提出。

本指南由中华中医药学会归口。

本指南负责起草单位：北京大学肿瘤医院、中国中医科学院西苑医院

本指南参与起草单位：国家中医药管理局重大疑难疾病中西医结合试点项目（结直肠癌）—结直肠癌疼痛子项目组（北京大学肿瘤医院、中国中医科学院西苑医院）

本指南主要起草人：李萍萍、杨宇飞、吴煜、孙红、薛冬、李占东、王薇、张彤、崔宁、刘倩、何英剑。

引　言

癌性疼痛（cancer pain）是指由癌症引起或抗癌治疗所致的疼痛。癌痛常表现为慢性疼痛，是肿瘤常见的主要症状之一。据统计，约 1/3 接受癌症治疗的患者出现疼痛，超过 2/3 的进展期癌症患者出现疼痛，约 50%疼痛为中度至重度，其中约 30%为重度疼痛。癌痛给患者造成极大的身心负担，严重影响了患者的生活质量。国家卫计委高度重视癌痛的管理工作，2011 年卫生部办公厅印发了《癌症疼痛诊疗规范（2011 年版）的通知》，启动了“癌痛规范化治疗示范病房创建活动”。在中国抗癌协会癌症康复与姑息治疗专业委员会的引领下，在姑息和疼痛领域专家的努力和广大医务人员的积极参与下，癌痛规范化治疗得到了较为广泛的推广。使更多疼痛患者得到了重视和治疗。癌痛管理的目标，是有效缓解疼痛，使患者获得日常活动能力和心理社会功能。在结直肠癌疼痛的规范化治疗中，我们发现中药的使用较为普遍。西药治疗癌痛，疗效确切，起效快，但具有比较明显的毒副作用[1]。中医药治疗疼痛历史悠久，古方众多。近年来国内大量文献报道了采用中医药内服、外用、针灸等方法开展对癌性疼痛的治疗，具有毒副作用小、使用安全、无成瘾性和无戒断性等优势[2]。为了更好地开展结直肠癌中西医结合重大疑难项目，我们在《癌痛规范治疗中成药合理使用专家共识》（中国疼痛医学杂志 Chinese Journal of Pain Medicine 2021, 27 (1) ）的基础上，结合肠癌疼痛特点，制定了《结直肠癌疼痛中西医结合诊疗指南》。本方案分以下几个方面：结直肠癌疼痛的病因及分类、结直肠癌疼痛的评估、结直肠癌疼痛的中西医结合治疗等。本方案推荐依据包括：NCCN 成人癌痛指南（2020 版）、北京市癌症疼痛治疗规范（2017 版）、难治性癌痛专家共识（2017 年版）、中华人民共和国药典（2015 版）、中华人民共和国药典.临床用药须知.中药成方制剂卷（2010 版）、中医经典著作、临床研究文献等。

结直肠癌疼痛中西医结合诊疗指南

1 范围

本方案规定了结直肠癌疼痛的病因及分类、评估、中西医结合治疗的内容。
本方案适用于结直肠癌疼痛中医、中西医结合临床诊疗。

2 规范性引用文件

《北京市癌症疼痛治疗规范》（2017 版）；
《NCCN clinical practice guidelines in Oncology:Adult Cancer Pain》（2020 版）；
《晚期癌症患者合并肠梗阻治疗的专家共识》（2007 年版）。
《难治性癌痛专家共识》（2017 年版）
《中华人民共和国药典》（2015 版）
《中华人民共和国药典.临床用药须知.中药成方制剂卷》（2010 版）

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准

3.1 结直肠癌 Colorectal cancer

胃肠道中常见的恶性肿瘤，包括结肠癌和直肠癌，早期症状不明显，随着癌肿的增大而表现排便习惯改变、便血、腹泻、腹泻与便秘交替、局部腹痛等症状，晚期则表现贫血、体重减轻等全身症状。其发病率在消化系统中仅次于胃癌，位于我国常见肿瘤第3位。

3.2 疼痛 pain

国际疼痛学会疼痛最新的定义为“疼痛是一种与实际或潜在的组织损伤相关的不愉快的感觉和情绪情感体验，或与此相似的经历。

“痛，病也”(《说文·疒部》)。癌症相关疼痛在中医文献中常出现在癥、瘕、积聚、瘤、石、乳岩、石疽、噎膈、反胃、脏毒等及其所致的气血衰败诸病候中。

结直肠癌疼痛（colorectal cancer pain），是指因结直肠癌直接侵犯或者其他脏器转移、抗肿瘤治疗等原因引起的疼痛。

4 结直肠癌疼痛的流行病学

结直肠癌为我国高发肿瘤，2015年中国恶性肿瘤流行情况分析显示，结直肠癌位居我国恶性肿瘤发病第3位，位居我国城市恶性肿瘤发病第2位；位居我国恶性肿瘤死亡人数第5位。大便习惯改变、便血、腹痛为结直肠癌常见首发症状，腹痛或腹部不适的发生率大约为40%。晚期结直肠癌高达70%合并疼痛，严重影响患者的生活质量。

5 结直肠癌疼痛的发病机制和病因病机

5.1疼痛病因

（1）肿瘤相关性疼痛：因为结直肠癌直接侵犯、压迫局部组织，或者结直肠癌肝转移、肺转移、淋巴结转移、恶性肠梗阻等所致。

（2）抗肿瘤治疗相关性疼痛：常见于结直肠癌手术、直肠放射治疗、化疗药物（如奥沙利铂）治疗等抗肿瘤治疗所致。

5.2疼痛分类。

疼痛按病理生理学机制，主要可以分为两种类型：伤害感受性疼痛和神经病理性疼痛。

（1）伤害感受性疼痛：因有害刺激作用于躯体或脏器组织，使该结构受损而导致的疼痛。伤害感受性疼痛与实际发生的组织损伤或潜在的损伤相关，是机体对损伤所表现出的

生理性痛觉神经信息传导与应答的过程。结直肠癌的伤害感受性疼痛主要表现为内脏痛，表现为弥漫性疼痛和绞痛，定位不够准确。

（2）神经病理性疼痛：由于外周神经或中枢神经受损，痛觉传递神经纤维或疼痛中枢产生异常神经冲动所致。神经病理性疼痛可以表现为刺痛、烧灼样痛、放电样痛、枪击样疼痛、麻木痛、麻刺痛、幻觉痛及中枢性坠胀痛，常合并自发性疼痛、触诱发痛、痛觉过敏和痛觉超敏。

5.3中医对结直肠癌疼痛的认识

祖国医学对大肠癌的病因病机、临床表现均有所记载，“伏梁”、“肠覃”、“肠痈“、“脏毒”、“锁肛痔”、“下血”等均符合对大肠癌的描述。对于大肠癌疼痛，祖国医学的经典著作中也有详细的描述，如《素问.腹中论》：“黄帝问曰：病有少腹盛者，上下左右皆有根，此为何病？可治不？岐伯曰：病名曰伏梁……人有身体髀股胫皆肿，环脐而痛，是为何病？岐伯曰：病名伏梁，此风根也，其气溢于大肠而著于盲，盲源在脐下，故环脐而痛也。”《金匮要略.疮痈肠痈浸淫病脉证并治第十八》：“肠痈之为病，其身甲错，腹皮急，按之濡，如肿状，腹无积聚，身无热，脉数，此为腹内有痈脓，薏苡附子败酱散主之……肠痈者，少腹肿痞，按之即痛，如淋，小便自调，时时发热，自汗出，复恶寒，其脉迟紧者脓未成，可下之，当有血；脉洪数者，脓已成，不可下也，大黄牡丹皮汤主之”。清代唐容川《血证论》中有“脏毒者，肛门肿硬，疼痛流血。”及《肘后备急方》认为“腹中有物如石，痛如刺，昼夜啼呼，不治之百日死。”肠癌疼痛的原因很多，但不外乎虚实，即“不通”与“不荣”。实证由于情志不畅、宿食积滞、寒、湿、痰饮、瘀血等因素均可引起气的运行失调，气机逆乱，血脉瘀阻，经络不通，即不通则痛。虚证则由于肿瘤日久，正气受损，气血阴阳不足，脏腑经络失于荣养或温煦而致不荣则痛。中晚期肠癌的疼痛临床上更以虚实夹杂之证常见。针对“不通”采用活血化瘀、温经散寒、化痰散结、疏肝理气、清热解毒等法。针对“不荣”采用益气养血、调和阴阳、甘温缓急等治法。

6 结直肠癌疼痛的诊断

结直肠癌疼痛的评估{参照《北京市癌症疼痛治疗规范》（2017 版）NCCN clinical practice guidelines in Oncology:Adult Cancer Pain》（2020 版）执行}

应该对结直肠癌患者进行疼痛筛查，在此基础上进行详尽的癌痛评估。癌痛评估是合理、有效进行止痛治疗的前提，应当遵循“常规、量化、全面、动态”的原则。

6.1 常规评估原则

癌痛常规评估是指医护人员主动询问癌症患者有无疼痛，常规性评估疼痛病情，并且及时进行相应的病历记录，一般情况下应当在患者入院后 8 小时内完成。对于有疼痛症状的癌症患者，应当将疼痛评估列入护理常规监测和记录的内容。进行疼痛常规评估时应当注意鉴别疼痛爆发性发作的原因，例如需要特殊处理的病理性骨折、脑转移、合并感染以及肠梗阻等急症所致的疼痛。

6.2 量化评估原则

癌痛量化评估是指采用疼痛程度评估量表等量化标准来评估患者疼痛主观感受程度，需要患者的密切配合。量化评估疼痛时，应当重点评估最近 24 小时内患者最严重和最轻的疼痛程度，以及平常情况的疼痛程度。量化评估应在患者入院后 8 小时内完成。癌痛的量化评估，通常使用数字分级法(NRS)、面部表情评估量表法及主诉疼痛程度分级法(VRS)三种方法。详见资料性附录 2。

6.3 全面评估原则

癌痛全面评估是指对癌症患者的疼痛及相关病情进行全面评估，包括疼痛病因和类型（躯体性、内脏性或神经病理性），疼痛发作情况（疼痛的部位、性质、程度、加重或减轻的因素），止痛治疗情况、重要器官功能情况、心理精神情况，家庭及社会支持情况以及既往史(如精神病史，药物滥用史)等。应当在患者入院后 8 小时内进行首次评估，并且在 24 小时内进行全面评估，在治疗过程中，应实施及时、动态评估。

癌痛全面评估，通常使用《简明疼痛评估量表(BPI)》（见附件 2），评估疼痛及其对患者情绪、睡眠、活动能力、食欲、日常生活、行走能力以及与他人交往等生活质量的影响。

应当重视和鼓励患者表达对止痛治疗的需求和顾虑，并且根据患者病情和意愿，制定患者功能和生活质量最优化目标，进行个体化的疼痛治疗。

6.4 动态评估原则

癌痛动态评估是指持续性、动态地监测、评估癌痛患者的疼痛症状及变化情况，包括疼痛病因、部位、性质、程度变化情况、爆发性疼痛发作情况、疼痛减轻和加重因素，止痛治疗的效果以及不良反应等。动态评估对于药物止痛治疗中的剂量滴定尤为重要。在止痛治疗期间，应当及时记录用药种类、剂量滴定、疼痛程度及病情变化。

6.5 结直肠癌疼痛的中医辨证分型

①湿热证：症见肛门灼热疼痛、便中夹血或里急后重等，舌红苔黄腻，脉滑数。

②血瘀证：症见腹部刺痛，痛有定处，拒按，夜间痛甚等。舌淡紫或有斑点,苔滑,脉涩，

③气滞证：症见腹胀腹痛，胸胁痞满，嗳气频作，大便干结，纳食减少等。舌淡苔薄黄，脉弦。

④阳虚证：症见腹痛隐隐，遇寒加重，大便稀溏，四肢不温等。舌淡胖苔白滑，脉沉迟无力。

⑤阴虚证：症见腹痛隐隐，时隐时现，绵绵不休，四肢筋脉拘挛等。舌红少苔，脉弦细数。

7 结直肠癌疼痛的中西医治疗

7.1治疗原则

结直肠癌疼痛应当采用综合治疗的原则，根据病人的病情和身体状况，快速、有效地消除疼痛，预防和控制药物的不良反应，降低疼痛及治疗带来的心理负担，争取使病人的疼痛得到有效缓解，同时保持病人的功能和舒适度。

7.2西医治疗方法{参照《北京市癌症疼痛治疗规范》（2017版）NCCN clinical practice guidelines in Oncology:Adult Cancer Pain》（2020版）执行}

癌痛的治疗方法包括：病因治疗、镇痛药物治疗和非药物治疗。

7.2.1针对病因治疗癌痛的主要病因如与癌症直接相关，给予抗肿瘤治疗，如手术、放射治疗或化学治疗等，可能解除癌痛。

7.2.2镇痛药物治疗

基本原则：根据世界卫生组织 (WHO)“癌痛三阶梯镇痛治疗”指南，使用镇痛药物治疗的五项基本原则如下：

①口服给药：口服为首选给药途径，对不宜口服的病人可选用其他给药途径（静脉、皮下、直肠、经皮给药等）。

②按阶梯用药：指应当根据病人疼痛程度，有针对性地选用不同强度的镇痛药物。A.轻度疼痛：NRS≤3 分，可选用非甾体抗炎药物 (NSAID)，如果存在使用非甾体抗炎药物的禁忌证，也可考虑使用小剂量阿片类药物；B.中度疼痛：3 < NRS < 7分，可使用弱阿片药物，也可使用小剂量强阿片类药物； C. 重度疼痛：NRS≥7分，可选用强阿片类药，并可联合使用非甾体抗炎药物。

③按时用药：指按规定时间间隔规律性给予镇痛药。按时给药有助于维持有效的血药浓度。目前，缓释药物临床使用日益广泛，强调以缓释阿片药物作为基础用药的镇痛方法，在滴定和出现爆发痛时，可给予即释阿片类药物对症处理。如起始使用即释阿片类药物进行滴定的癌痛病人，24 小时后即可转换为等效剂量的口服缓释阿片类药物。

④个体化给药：指按照病人病情和癌痛缓解药物剂量，制订个体化用药方案。使用阿片类药物时，由于个体差异，阿片类药物无标准用药剂量，应当根据病人的病情，使用足够剂量药物使疼痛得到缓解。同时，还应鉴别是否有神经病理性疼痛的性质，考虑联合用药可能。

⑤注意具体细节：对使用镇痛药物的病人，要密切观察其疼痛缓解程度和机体反应情况，注意药物联合应用的相互作用，并及时采取必要措施以尽可能减少药物的不良反应，提高病人的生活质量。

7.2.3非药物治疗

用于癌痛治疗的非药物治疗方法主要有：微创介入治疗、针灸、经皮电刺激等物理治疗、认知行为训练、社会心理支持治疗等。适当应用非药物疗法，可作为药物镇痛治疗的有益补充，与镇痛药物治疗联用，可增加镇痛治疗的效果。

7.3中医治疗方法

7.3.1中药在结直肠癌疼痛治疗中的主要作用

在治疗癌痛中，中西医有不同的作用特点。中医在癌痛治疗中也发挥着其独特的作用。主要有以下几个方面：

①镇痛作用（Ⅰa级证据）

根据疼痛症状特点和病机，施以理气、活血、散寒、解毒等方法，通过疏通与扶正、协调阴阳气血、平衡经络脏腑而缓解疼痛。

②改善阿片类药物的不良反应（Ⅱa级证据）

阿片类药物常见的不良反应包括：便秘、恶心呕吐、嗜睡、尿潴留、眩晕、瘙痒等。其中最常见的不良反应是便秘，其次是恶心呕吐。中药治疗阿片类药物的不良反应，尤其是便秘，根据辨证特点用药，往往会取得较好疗效。

7.3.2止痛中药的应用原则

止痛中药是指可以缓解疼痛症状的中药，其应用原则如下：

①在WHO三阶梯止痛原则和NCCN成人癌痛指南的原则指导下，根据疼痛程度和目前中药的临床证据，合理使用止痛中药。

②根据疼痛寒热虚实的表现特点，辨证用药。如血瘀疼痛以刺痛为特点，应使用活血止痛中药，气滞疼痛以胀痛为特点，应使用理气止痛中药等。

③应了解止痛中成药的功能主治和适应症，避免出现不良反应。如使用活血止痛中药时，应注意患者是否有出血倾向，避免引起出血等。

7.3.3结直肠癌疼痛的中医辨证治疗（Ⅳ级证据，弱推荐）

①湿热证

治法：清热止痛

推荐方药：槐角丸《太平惠民和剂局方》，药物组成：槐角20g、地榆10g、当归10g、防风10g、黄芩10g、枳壳10g。

②血瘀证

治法：活血止痛

推荐方药：血府逐瘀汤《医林改错》，药物组成：桃仁12g、红花9g、当归9g、生地黄9g、牛膝9g、川芎4.5g、桔梗4.5g、赤芍6g、枳壳6g、甘草6g、柴胡3g。

③气滞证

治法：行气止痛

推荐方药：六磨饮子《世医得效方》，药物组成：槟榔9g、沉香9g、木香9g、乌药9g、大黄9g、枳壳9g。

④阳虚证

治法：温阳止痛

推荐方药：理中汤《伤寒论》，药物组成：人参9g、白术9g、炙甘草9g、干姜9g。

⑤阴虚证

治法：养阴止痛

推荐方药：芍药甘草汤《伤寒论》，药物组成：白芍药12g、炙甘草12g。[1]

7.3.4结直肠癌疼痛常用中成药证据分级和干预措施推荐等级

根据肿瘤和疼痛的病因病机，药物的功能主治，结直肠癌疼痛常用中成药分为活血消癥止痛、解毒消癥止痛、理气止痛，清热止痛、散寒止痛。常用剂型包括口服剂型、注射剂、外用剂型等。在临床应用时，应该首选口服剂型，在中医辨证前提下酌情选用。

（1）活血消癥止痛类

①复方斑蝥胶囊[2] Ⅱ级证据，弱推荐。

推荐用于消化道肿瘤引起的肝区、腹部疼痛，痛有定处，疼痛拒按者。

②复方夏天无片[3-4]　Ⅱ级证据，弱推荐。

复方夏天无片镇痛作用已证实的作用机制如下：现代药理研究表明夏天无植物中含有夏天无总碱，主要有效成分为原阿片碱和延胡索乙素等，原阿片碱具有抗肾上腺素、解痉

镇痛之功效；延胡索乙素具有解痉、镇痛、活血之功效。推荐单独使用，治疗轻度癌痛属于气滞血瘀证者。

（2）解毒消癥止痛类

①华蟾素胶囊（片、注射液）[5-19]　Ⅰ级证据，强推荐。

华蟾素缓解癌性疼痛已证实的作用机制如下：通过抗肿瘤作用而间接发挥镇痛作用；华蟾素缓解肿瘤癌痛的机制可能与免疫细胞的抗炎作用有关；可能通过选择性阻断外周阿片受体达到镇痛；华蟾素中吲哚类生物碱可直接作用于中枢神经系统，提高痛阈值，可达到镇痛效果。

华蟾素对消化道肿瘤引起的疼痛疗效较好，可以应用于肺癌、骨转移癌、食管癌、口腔癌等引起的疼痛。

推荐用于消化道肿瘤引起的疼痛，表现为红肿热痛，辨证属于热毒内蕴证者。

（3）理气止痛类

①元胡止痛片（颗粒）[20]　Ⅱ级证据，弱推荐。

推荐用于胸痛、胃痛、两胁痛、头痛属于气滞血瘀证者。

（4）散寒止痛类

①桂参镇痛合剂[21-23]　Ⅰ级证据，强推荐。

推荐单独使用，用于癌性疼痛属脾肾阳虚或兼气虚血瘀证者。

②草乌甲素片[24]　Ⅰ级证据，强推荐。

推荐单独使用治疗轻、中度癌痛，与阿片类药物联合应用治疗中重度癌痛。

（5）清热止痛类

①新癀片[25-26]　Ⅱ级证据，弱推荐。

可用于胰腺癌、肝癌、肺癌、骨转移癌、消化道肿瘤、头颈部肿瘤引起的疼痛。

推荐单独应用治疗消化道肿瘤引起的胁痛、腹痛属于轻中度癌痛者，或者与阿片类药物联合应用治疗中、重度癌痛。

（8）注射剂型

①复方苦参注射液[27-33]　Ⅰ级证据，强推荐

复方苦参注射液可用于骨转移疼痛、肺癌、胰腺癌、肝癌、消化道肿瘤、放射性粘膜炎等引起的疼痛。

推荐用于消化道肿瘤等引起的疼痛属于湿热瘀毒内结证者。

②华蟾素注射液（胶囊、片）[5-19]　Ⅰ级证据，强推荐。

华蟾素对消化道肿瘤引起的疼痛疗效较好，还可以应用于肺癌、骨转移癌、食管癌、口腔癌等引起的疼痛。

推荐用于消化道肿瘤引起的疼痛，表现为红肿热痛，辨证属于热毒内蕴证者。

③康莱特注射液（胶囊）[34-42]　Ⅰ级证据，强推荐。

康莱特可用于胰腺癌、肺癌、骨转移癌、消化道肿瘤、乳腺癌等引起的疼痛。

推荐用于消化道肿瘤引起的疼痛偏虚证者。

（9）外用剂型

①湿润烧伤膏[43]　Ⅱ级证据，弱推荐。

推荐外用，用于鼻咽癌、食管癌、乳腺癌、宫颈癌、直肠癌等接受放射治疗引起的皮肤损伤灼热疼痛者，用于化疗引起的静脉炎见血管皮肤红肿疼痛者。

②如意金黄散[44]　Ⅱ级证据，弱推荐。

推荐外用，用于预防或治疗化疗药物外渗所致的红肿热痛，肝癌导致的肝区疼痛。

7.4结直肠癌疼痛中西医结合治疗流程

7.4.1止痛中药与癌痛三阶梯治疗的结合

中医和西医学科不同，虽然对疼痛的病机病理认识不同，用药不同，但对癌痛病人的治疗理念是一致的，即快速、有效地消除疼痛。同样可以用客观的方法评价病人对疼痛程度变化的主观感受，以评价中医干预方法是否有效。因此，在用中药治疗癌痛时，仍提倡与三阶梯镇痛原则相结合，即及时评价疼痛程度变化，24小时疼痛未达到病人可以耐受的程度时，应及时调整药物，或酌情使用阿片类药物，或请专科会诊，争取使病人的疼痛得到快速、有效的缓解。同时，预防和控制药物的不良反应；保持病人的功能和舒适度；降

低疼痛及治疗带来的心理负担。在WHO三阶梯镇痛原则指导下，根据疼痛程度和目前中药的临床证据，合理使用止痛中药。

（1）轻度疼痛：可根据病人意愿、基础疾病情况辨证选择中药止痛或非甾类镇痛药。

（2）中重度疼痛：依据疼痛性质特点选择适宜止痛中药，或阿片类药物镇痛。同时密切观察，及时调整药物。

（3）复杂疼痛建议及时请疼痛专科或多学科会诊，以使病人的疼痛得到快速有效的缓解。

7.4.2 根据疼痛性质合理使用中成药

疼痛性质	疼痛特点	治疗原则	推荐用药
刺痛	疼痛如针刺，称为刺痛。其特点是疼痛的范围较小。部位固定不移。多因瘀血所致。全身各处均可出现刺痛症状，但以胸胁、胃脘、小腹最为多见。	活血止痛	复方斑蝥胶囊、复方夏天无片
胀痛	痛且有胀感，为胀痛。在身体各部位都可以出现，但以胸胁、胃脘、腹部较为多见。多因气机郁滞所致。	理气止痛	元胡止痛片
灼痛	痛处有烧灼感，称灼痛。其特点是感觉痛处发热，痛处局部亦可有触热感，多喜冷凉。为瘀毒化热所致，辨为热证。	解毒止痛	华蟾素片（胶囊）、华蟾素注射液、复方苦参注射液、新癀片、湿润烧伤膏、如意金黄散
隐痛	隐隐作痛，时隐时现，绵绵不休，称隐痛。其特点是疼痛轻微，痛而喜按，气短神倦。多因气血不足，导致经脉气血运行滞涩所致。辨为虚证。	益气止痛 养阴止痛	气虚疼痛用：康莱特注射液（胶囊）
窜痛	疼痛部位游走不定或走窜攻痛称为串痛。其特点是痛处不固定，或者感觉不到确切的疼痛部位。多为风邪阻滞气机，产生疼痛。	疏肝止痛	元胡止痛片
冷痛	痛处有冷感。其特点是感觉痛处发凉，如病在浅表，局部触及可有凉感，多喜温热。此为寒凝筋脉或阳气不足而致。	温中止痛	草乌甲素片、参桂镇痛合剂

7.5 阿片类药物引起的便秘中成药的使用

阿片类药物常见的不良反应包括：便秘、恶心呕吐、嗜睡、尿储留、眩晕、瘙痒等。其中最常见的副作用是便秘，其次是恶心呕吐。据报道癌痛患者中阿片类相关性便秘（Opioid-induced constipation，OIC）的发生率高达 95%。OIC 与年龄、性别和经济地位无关。中医治疗便秘，根据辨证特点用药，往往会取得较好疗效。治疗便秘常用中成药如下：

药物分类	药物名称	功效
润肠通便	通便灵胶囊	泻热导滞，润肠通便
	麻仁润肠丸	润肠通便
	麻仁软胶囊	润肠通便
	通幽润燥丸	清热导滞，润肠通便
	复方芦荟胶囊	调肝益肾，清热润肠，宁心安神
泻火通便	当归龙荟丸	泻火通便
	新清宁片	清热解毒，泻火通便
理气通便	四磨汤口服液	顺气降逆，消积镇痛
益气通便	芪蓉润肠口服液	益气养阴，健脾滋肾，润肠通便
消积通便	六味安消胶囊	健脾和胃，消积导滞，活血镇痛

7.6 结直肠癌常见疼痛的中西医结合诊疗方案（结直肠癌疼痛合并肠梗阻、放射性直肠损伤）：

7.6.1 结直肠癌疼痛合并肠梗阻的中西医结合诊疗方案

7.6.1.1 流行病学

晚期原发或转移肿瘤并发肠梗阻的发生率为 5%-43%，常见原发肿瘤为卵巢癌、结直肠癌和胃癌[46]。其中结直肠癌患者约 7%-29%并发肠梗阻，表现为完全或不完全性的梗阻[46]。常见症状包括恶心、呕吐、腹痛、腹胀、排便排气消失等，其临床表现与肠梗阻部位及程度相关。

7.6.1.2 诊断

腹痛是恶性肠梗阻常见症状，出现腹痛的肠癌患者需要对腹痛原因进行鉴别诊断，其常见病因包括肿瘤直接侵犯或压迫局部组织、术后肠粘连、肠梗阻、肠穿孔等。

恶性肠梗阻诊断要点包括：(1)恶性肿瘤病史；(2)既往未行或曾行腹部手术、放疗或腹腔内灌注药物治疗；(3)间歇性腹痛、腹胀、恶心、呕吐等症状，伴或不伴肛门排气或排便；(4)腹部体检可见肠型、腹部压痛、肠鸣音 亢进或消失；(5)腹部 CT 或腹部 x 线平片可见肠腔明显扩张和多个液平面。腹部 x 线平片检查是诊断肠梗阻常用的检查方法。在有条件的情况下，推荐腹部 CT 扫描作为肠梗阻影像学诊断的首选方法。

7.6.1.3 西医治疗

伴肠梗阻或不全肠梗阻的癌痛患者西医治疗方案（参照《晚期癌症患者合并肠梗阻治疗的专家共识》（2007 年版）执行）[46]

治疗方法主要包括：手术治疗、药物治疗、补液、胃肠外营养支持、自张性金属支架、鼻胃管引流、胃造瘘。

其中药物治疗种类主要包括：止痛药、止吐药、激素类药及抗分泌药。止痛药的选择：（1）阿片类药：为阿片受体激动剂，作用于中枢阿片受体产生镇痛作用。阿片类止痛药是控制恶性肠梗阻腹痛最有效的药物，对持续性疼痛和绞痛均有效。应用时可根据病情选择吗啡、羟考酮、芬太尼等强阿片类止痛药。对于无法口服用药的患者，首选芬太尼透皮贴剂，也可采用吗啡皮下或静脉注射，丁丙诺啡舌下含片、患者自控镇痛术等。（2）抗胆碱药：外周胆碱能受体阻滞剂，缓解胃肠道平滑肌痉挛和抑制蠕动。抗胆碱类药物包括氢溴酸东莨菪碱、山莨菪碱等，可用于阿片类药物单药控制不佳的腹部绞痛。抗胆碱类药物不能透过血脑屏障，因此中枢性不良反应(如失眠和欣快)较阿片类药物低。

7.6.1.4 中医治疗（伴不全肠梗阻的结直肠癌疼痛患者中医治疗方案）

（1）治疗原则

止痛治疗：配合阿片类止痛药物，外用中药止痛、针灸止痛，以理气温中、缓急止痛

为主，随证加减。缓解患者不全肠梗阻的治疗：不全肠梗阻可采用口服通便药物，可配合外用中药、针灸等理气通便治疗。

（2）治疗方案（Ⅱ级证据，弱推荐）

内服法：以泻下通腑、润肠行气通便为主要治法，推荐承气汤加减或麻子仁汤加减治疗。[47-48]

外治法：主要包括中药保留灌肠、中药穴位外敷、针灸治疗。[49]

中药保留灌肠：以泻下通腑为主要治法，推荐采用承气汤为主加减治疗。[50-51]

中药穴位外敷：以温中止痛、理气消胀为主要治法，主要穴位有神阙穴、中脘、足三里。[49、52]

针灸治疗：主要穴位包括足三里、上巨虚、下巨虚、天枢、中脘、内关穴等。采用温阳散寒、行气通腑之法，可联合神阙穴隔姜温灸。[49、53]

7.6.2 放射性直肠损伤的中西医结合诊疗方案

7.6.2.1 流行病学

放射性直肠损伤是消化道肿瘤以及妇科恶性肿瘤患者放疗中最常见的不良反应。放射性直肠损伤发生率为 5%-17%[54]。其临床表现多为恶心、呕吐、腹痛、腹泻、排出血样或黏液便。放射性直肠损伤疼痛表现为局部的红肿热痛、肛门灼热痛、肛门下坠感等。

7.6.2.2 诊断

放射性直肠损伤（RRI）是指因盆腔恶性肿瘤（宫颈癌、子宫内膜癌、前列腺癌、膀胱癌、直肠癌、肛管癌等）接受放射治疗而导致的直肠放射性物理损伤，RRI 可分为急性放射性直肠损伤（RARI）和慢性放射性直肠损伤（RLRI），通常以 3 个月为分界[55]。

7.6.2.3 西医治疗（参照《中国放射性直肠损伤多学科诊治专家共识》2021 版执行）[55]

（1）一般治疗：包括健康宣教、心理干预、饮食调节及排粪管理、营养治疗等。

（2）急性放射性直肠损伤（RARI）的治疗

由于 RARI 多数是自限性的，故一般不建议暂停或者终止放疗，可对急性期出现的症状进行药物对症治疗。常用药物选择抗炎类药物包括非甾体类消炎药（柳氮磺胺砒啶、巴柳氮、美沙拉嗪、奥沙拉嗪等）和类固醇类药物、益生菌及其他对症治疗药物。

（3）慢性放射性直肠损伤（RLRI）的治疗

RLRI 患者应依据病变的严重程度和疾病不同分型特点，选择药物治疗、内镜下治疗或手术治疗。药物治疗包括抗炎类药物、抗生素类药物、抗氧化剂、黏膜保护剂及短链脂肪酸等。疼痛患者根据疼痛程度合理使用西药镇痛药物，可酌情使用吲哚美辛栓、硫酸吗啡栓等肛门途径用药。

7.6.2.4 中医治疗

（1）治疗原则

放射性直肠损伤多分为湿热内蕴型、脾胃虚弱型、脾肾阳虚型，急性期湿热内蕴型常见，多采用凉血解毒缓急止痛之法。慢性期脾胃虚弱型、脾肾阳虚型多见，常运用补虚温中健运、涩肠止泻固阴之法[56]。可给予中药口服、灌肠、针灸等方法治疗。

（2）治疗方案（Ⅱ级证据，弱推荐）

内服法：急性期采用凉血解毒缓急止痛之法，推荐白头翁汤或者葛根芩连汤加减。慢性期常运用补虚温中健运、涩肠止泻固阴之法，脾胃虚弱的推荐参苓白术散加减，脾肾阳虚的推荐真人养脏汤和椿根皮散。[57-58]

外治法：主要包括中药保留灌肠、针灸治疗。

中药保留灌肠：推荐汤剂十灰散、白头翁汤，中成药康复新液。[59-60]

针灸治疗：主要穴位包括天枢、关元、上巨虚、足三里、脾俞等。[57]

8 推荐意见及证据描述

8.1文献检索结果

英文检索结果：无中医药治疗结直肠癌的文献，有针灸治疗结直肠癌术后恢复和奥沙利铂末梢神经毒性的文献，无结直肠癌疼痛的针灸文献。结直肠癌疼痛的主要中医辨证及代表方剂：检索到1篇芍药甘草汤，未检索到其他关于结直肠癌疼痛的中医辨证的临床研究文献。

8.2中成药治疗结直肠癌疼痛检索结果

（1）复方斑蝥胶囊

复方斑蝥胶囊，无专门针对结直肠癌疼痛的研究，有一篇随机对照研究中提示复方斑蝥胶囊联合化疗对217例中晚期恶性肿瘤具有减轻疼痛的作用，其中大肠癌疼痛患者29例。证据等级Ⅱ级，推荐意见为弱推荐。

（2）复方夏天无片

复方夏天无片，无专门针对结直肠癌疼痛的研究，有一篇随机对照研究中提示对于轻度癌痛76例复方夏天无片与双氯芬酸纳肠溶片疗效相当，副作用减少，其中结肠癌19例。有一篇对照研究中提示胃肠道肿瘤疼痛患者30例，与常规化疗相比复方夏天无片联合化疗止痛效果明显，其中结直肠癌15例。证据等级Ⅱ级，推荐意见为弱推荐。

（3）华蟾素

关于华蟾素治疗结直肠疼痛的研究15篇，其中华蟾素治疗癌痛Meta分析1篇，华蟾素胶囊联合化疗治疗晚期结直肠癌的系统评价与Meta分析2篇。许晶等做了华蟾素治疗癌痛有效性和安全性的系统评价和 Meta 分析，最终纳入 10 个研究，总样本量为 1 293 例，试验组 648 例，对照组 645 例，所纳入研究总体质量普遍偏低。Meta 分析结果显示: 华蟾素联合西药止痛药治疗癌痛在近期疼痛缓解效果、提高生活质量和便秘、恶心呕吐、头晕、嗜睡、厌食等不良反应发生方面优于单用西药止痛药，并且具有止痛起效时间短，维持时间长的优势，但不能降低排尿困难的发生率。金金等做了华蟾素胶囊联合化疗治疗晚期结直肠癌的系统评价与Meta分析，共纳入 9 项 RCTs涉及 658 例结直肠癌患者，试验组均为华蟾素胶囊联合化疗药物，对照组为单用化疗药物。Meta 分析结果显示，华蟾素胶囊联合化疗药物在近期有效率、患者生活质量、疼痛缓解率方面明显优于单纯使用化疗药物，并可降低白细胞毒性、胃肠不良反应、肝功能异常、手足麻木的发生率。彭莹莹等做了华蟾素胶囊联合奥沙利铂化疗方案治疗结直肠癌的 Meta 分析，共纳入 8 个 RCT研究，505 例结直肠癌患者，Meta 分析结果显示华蟾素胶囊联合奥沙利铂化疗方案治疗结直肠癌的临床疗效、生活质量、疼痛缓解优于对照组，不良反应低于对照组。RCT研究12篇，共纳入406肠癌疼痛患者。其中3篇为化疗联合华蟾素胶囊对疼痛控制效果优于单纯化疗，7篇为西医镇痛治疗联合华蟾素优于单纯西医镇痛治疗，1篇为伊班膦酸联合华蟾素注射液镇痛效果优于单纯伊班膦酸骨转移疼痛，1篇为华蟾素注射液与美施康定对比镇痛效果相当，但生活质量更优。证据等级为Ⅰ级，推荐意见为强推荐。

（4）元胡止痛片（颗粒）

元胡止痛片（颗粒），无专门针对结直肠癌疼痛研究，有一篇RCT研究提示元胡止痛胶囊联合吗啡缓释片对比单纯吗啡缓释片，镇痛效果相当，但元胡止痛片能够降低吗啡缓释片使用剂量及不良反应，具体病种不详。证据等级Ⅱ级，推荐意见为弱推荐。

（5）桂参镇痛合剂

无专门针对结直肠癌疼痛研究，有3篇RCT研究针对癌痛的随机对照研究，提及肠癌或者胃肠道肿瘤。研究显示桂参止痛合剂具有明显镇痛作用，对中晚期癌性疼痛患者止痛效果优于强痛定片，且有改善肿瘤患者临床症状、提高生活质量的作用，无恶心呕吐、便秘副作用。证据等级为I级，推荐意见为强推荐。

（6）草乌甲素片（胶丸）

无专门针对结直肠癌疼痛研究， 1篇单独应用草乌甲素治疗轻中度癌痛的随机对照研究，纳入肠癌13例，研究显示对于轻中度癌痛草乌甲素镇痛效果不劣于芬必得、曲马多，副作用更小，生活质量更佳。证据等级为I级，推荐意见为强推荐。

（7）新癀片

无专门针对结直肠癌疼痛研究，有一篇RCT研究联合美施康定治疗重度癌痛96例的随机对照研究，纳入结直肠癌8例，结果显示应用新癀片配合美施康定治疗重度癌痛患者可增加镇痛疗效，减轻便秘等副反应。有1篇病例观察单独应用新癀片治疗92例癌痛，纳入直肠癌4例，结果显示新瘤片对实体瘤所致的疼痛均有较好的效果，尤其是Ⅰ、Ⅱ级疼痛患者，不但起效较快，止痛维持时间较长，未发现恶心 、呕吐、腹痛、腹泻等副作用，但上消化道出血者禁用，胃、十二指肠溃疡患者慎用。证据等级Ⅱ级，推荐意见为弱推荐。

（8）复方苦参注射液

关于复方苦参注射液治疗结直肠疼痛的研究7篇，其中治疗癌痛Meta分析3篇，治疗结直肠疼痛RCT研究4篇。李德辉等通过对纳入的 9 篇文献、997例癌痛患者进行 Meta 分析，结果显示：与单纯用奥施康定治疗癌痛比较，复方苦参注射液联合奥施康定的镇痛有效率增加，病人生活质量提高，恶心呕吐等不良反应发生率降低。黄奕雪等共纳入 21 篇随机对照试验，包括1903个患者，复方苦参注射液联合止痛药对于癌痛的疗效优于单纯使用止痛药，且能够辅助降低单纯使用止痛药的不良反应。陈芝强等纳入7个随机对照试验，共558名患者，Meta分析结果显示：复方苦参注射液联合唑来膦酸治疗骨性癌痛患者在疼痛缓解率方面优于单用唑来膦酸治疗，且联合用药未明显增加毒副反应。一篇研究显示复方苦参注射液联合化疗治疗结直肠癌骨转移疼痛与单纯化疗组比较，疼痛有效率、生活质量均占优，纳入大肠癌82例。一篇研究显示复方苦参注射液联合奥施康定治疗中晚期肠癌癌性疼痛患者能有效减轻疼痛程度和提高生存质量，效果优于单纯奥施康定治疗，不良反应发生率相似，纳入大肠癌64例。另一篇文献研究显示复方苦参注射液联合奥施康定治疗中晚期肠癌癌性疼痛疼痛评分、疼痛缓解率、生活质量均优于单纯奥施康定组，纳入大肠癌100例。一篇研究应用艾灸配合复方苦参注射液治疗的直肠癌性疼痛，疼痛缓解率、疼痛强度差、生命质量评分均高于西药止痛组，纳入直肠癌60例。证据等级为I级，推荐意见为强推荐。

（9）康莱特注射液（胶囊）

关于康莱特注射液（胶囊）治疗结直肠疼痛的研究 9 篇，1 篇 meta 分析，8 篇 RCT 研究。廖剑锋等做了康莱特联合化疗与单纯化疗治疗结直肠癌的 meta 分析，纳入 9 篇研究，共 610 例患者，结果显示，康莱特联合化疗组治疗结直肠癌的疼痛总缓解率优于单独化疗治疗组。其中 1 篇研究采用奥施康定联合康莱特注射液治疗中晚期癌痛患者，与单独使用奥施康定相比，不仅有更好的镇痛作用，并可明显改善患者的生存质量，纳入直肠癌 10 例。一篇研究采用康莱特注射液+最佳支持治疗生活质量和癌痛缓解率优于最佳支持治疗，纳入肠癌 16 例。一篇康莱特注射液+营养支持治疗+三阶梯阵痛治疗对比营养支持治疗+三阶梯阵痛治疗，治疗组与对照组比较疼痛缓解率、KPS 评分、体重评分有明显提高。一篇康莱特注射液控制癌痛 及提高晚期癌症患者生存质量的多中心Ⅲ期研究，纳入 14 家肿瘤医院 376 例晚期癌症，其中伴有癌症疼痛患者 328 例, 占 87.23 % (328/376)，研究显示康莱特注射液癌症疼痛控制总有效率达 80.49 % (部分缓解 56.10%, 完全缓解 24.39 %) , 用药结束后疼痛缓解仍可维持 1～7 天以上, 且无成瘾性，纳入大肠癌 28 例。一篇研究显示康莱特与吗啡缓释片合用可明显提高重度癌性疼痛患者的镇痛效果，减少吗啡缓释片用量，改善患者生活质量。一篇研究显示最佳支持治疗联合康莱特能够有效改善老年晚期消化道肿瘤的生活质量、缓解疼痛，纳入大肠癌 15 例。一篇研究显示康莱特注射液联合 FOLFOX4 方案治疗晚期结直肠癌不仅能增加临床获益率，同时还能改善患者的身体状况和生活质量及缓解疼痛、降低不良反应的发生率，纳入大肠癌 60 例。一篇研究显示康莱特注射液联合 FOLFOX4 方案治疗晚期结直肠癌肝转移，联合化疗组在缓解患者的临床症状疗效较好, KPS 评分和疼痛缓解率均优于单纯化疗组, 而且联合化疗组化疗的不良反应也相应较轻，纳入大肠癌 66 例。证据等级为Ⅰ级，推荐意见为强推荐。

（10）湿润烧伤膏

RCT研究1篇，文献研究显示，湿润烧伤膏治疗放射性皮炎、疼痛缓解情况均优于红霉素软膏对照组，其中纳入直肠癌11例。证据等级Ⅱ级，推荐意见为弱推荐。

（11）如意金黄散

外用用于治疗化疗引起的静脉炎RCT研究1篇，研究显示醋调如意金黄散加冰敷治疗化疗药引起的非外渗性静脉炎疗效（86.27%）优于对照组硫酸镁（50.98%）。证据等级Ⅱ级，推荐意见为弱推荐。

资料性附录

附录 1 文献检索

1.1 临床研究文献检索的研究类型包括系统综述/Meta 分析、随机对照试验（RCT），检索数据库包括，中国知网、万方数据知识服务平台、重庆维普中文科技期刊数据库、中国生物医学文献服务系统， PubMed、MEDLINE。检索时间从建库至 2021 年 8 月 31 日。

1.2 检索策略

中文检索词：结肠癌 or 直肠癌 or 结直肠癌 or 大肠癌 or 胃肠道肿瘤 and 疼痛 or 癌性疼痛 or 癌痛 and 中药 or 中医药 or 中西医 or 中成药 or 针灸。

英文检索词：Colon Cancer or Rectal Cancer or Colorectal Cancer or Gastrointestinal Tumor And Pain or Cancer Pain And Traditional Chinese Medicine or Herbal Hedicine or Traditional Chinese and Western Medicine or Chinese Patent Medicine or Acupuncture or Traditional Medicine or Combined Medicine or Alternative Therapy or Supplementary Alternative Medicine。

检索字段：标题(title) 、摘要(abstract)、关键词(key words) 、全文(all fields)。

1.3 中成药治疗结直肠癌疼痛检索策略

（1）根据检索《中华人民共和国药典》（2015 版）、《中华人民共和国药典.临床用药须知.中药成方制剂卷》（2010 版）具有镇痛作用的中成药，共整理出 35 种中成药：金龙胶囊、复方斑蝥胶囊、复方夏天无片、小金丸（胶囊）、肝复乐片、槐耳颗粒、大黄䗪虫丸、化癥回生片、血府逐瘀口服液（丸）、华蟾素胶囊（片、注射液）、西黄丸（胶囊）、慈丹胶囊、平消胶囊（片）、安替可胶囊、元胡止痛片（颗粒）、气滞胃痛颗粒、柴胡舒肝丸、舒肝丸、十香止痛丸、桂参止痛合剂、草乌甲素片、桂枝茯苓丸、虚寒胃痛颗粒、新癀片、六神丸、梅花点舌丸、参芍片、阴虚胃痛颗粒（片）、复方苦参注射液、康莱特注射液（胶囊）、湿润烧伤膏、如意金黄散、奇正消痛贴膏、阿魏化痞膏、七厘散。

（2）中文检索词：中成药名称 and 疼痛 or 结肠癌or直肠癌or结直肠癌or大肠癌or胃肠道肿瘤为检索词进行检索，然后对检索出的文献进行筛选

（3）文献纳入标准：

纳入标准：（1）文献类型：临床研究文献，研究类型包括系统综述/Meta 分析、随机对照试验（RCT）、非随机临床对照试验、队列研究等；（2）研究对象：结直肠癌疼痛患者或者研究文献中包含结直肠癌疼痛患者；（3）每篇文献中病例观察的样本含量实验组和对照组均≥30 例；（4）结局指标: 文献中有明确的疼痛评估指标及疗效评价标准。

（4）筛选过程：由 2 位工作者独立根据纳入排除标准进行筛选，对筛选结果进行核对，若存在分歧，两者讨论决定，讨论后仍然不一致，由第三方裁决。筛选流程如下：a.排除重复文献；b.阅读题目、摘要初筛；c.阅读全文筛选；d.确定纳入文献。所有排除文献均需注明排除原因。

（5）提取。根据实际需求设计资料提取表，提取内容可包括研究者的基本信息（第一作者、发表年份等）、研究对象的基本特征（性别、年龄、病程等）、干预措施和对照措施的基本信息、结局指标和结果测量数据、风险偏移评价的主要因素等。由 2 位工作者独立对纳入文献进行资料提取，对筛选结果进行核对，若存在分歧，两者讨论决定，讨论后仍然不一致，由第三方方向裁决。首先通过阅读标题和摘要，排除明显不相关的文献后再阅读全文，进一步明确是否最终纳入进行定量分析。研究资料内容提取包括: ① 纳入研究的基本信息：第一作者、发表时间；② 受试者的基线特征：各组样本量、性别。③ 干预措施：中药干预方案、干预疗程及本研究关注的相关结局指标。

（6）综合可根据实际情况选择合适的证据综合方法。经济学评价：如有相关证据，可采用成本效果分析、成本效益分析或经济学模型。

1.4 检索结果

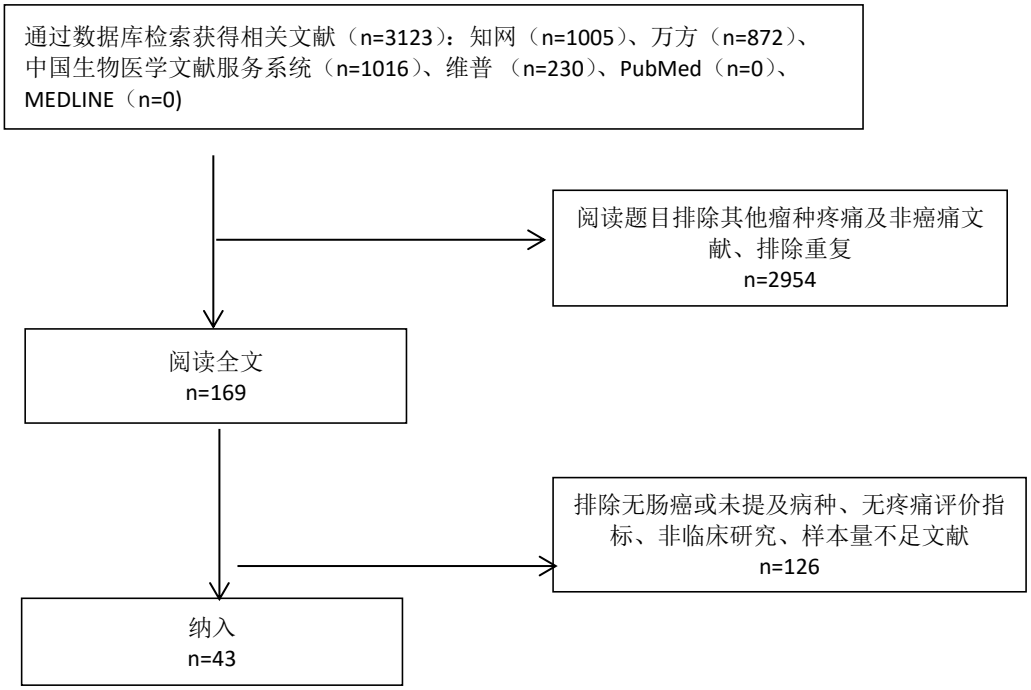
（1）英文检索结果：无中医药治疗结直肠癌疼痛的文献，有针灸治疗结直肠癌术后恢复和奥沙利铂末梢神经毒性的文献，无结直肠癌疼痛的针灸文献。

（2）结直肠癌疼痛的主要中医辨证及代表方剂：检索到一篇芍药甘草汤治疗肠癌的文献，其他代表方剂未检索到关于结直肠癌疼痛的中医辨证研究。

（3）中成药治疗结直肠癌疼痛检索结果

共检索到 11 种中成药有在结直肠癌疼痛中应用的文献报道，包括复方斑蝥胶囊、复方夏天无片、华蟾素、元胡止痛、桂参止痛合剂、草乌甲素、新癀片、康莱特、湿润烧伤膏、如意金黄散、复方苦参注射液。共检索出 3123 篇文献。其中中文文献 3123 篇，英文文献 0 篇。阅读题目排除其他瘤种疼痛及非癌痛文献后，剔除重复文献，获得文献 169 篇。再通过阅读全文和摘要，排除无肠癌或未提及病种、无疼痛评价指标、非临床研究、样本量不足文献 126 篇，最终获得与本研究的结局指标相关的文献共 43 篇，其中 43 篇中文文献和 0 篇英文文献。

1.5 文献具体筛选流程



附录 2 证据概要表

纳入研究	样本量干预组/对照组	其中纳入肠癌样本量	性别男/女	干预措施			结局指标
				治疗组	对照组	疗程/d	
杨昭，2020[1]	65/65	65/65	71/59	芍药甘草汤加减+三阶梯止痛	三阶梯止痛	28d	NRS 评分+③QOL 评分
董毅，2012[2]	109/108	14/15	153/64	常规化疗+复方斑蝥胶囊	常规化疗	不详	①NRS 评分+③KPS 评分
邹方友，2011[3]	38/38	9/10	42/34	复方夏天无片	双氯酚酸钠肠溶片	14	①VAS 评分+②
李琦，2008[4]	30/30	9/6	42/18	AF 方案化疗+复方夏天无片	AF 方案化疗	63	①《现代麻醉学》分级标准

杨宏，2018[8]	46/46	46/46	57/35	SOX 方案化疗+华蟾素	SOX	84	①NRS 评分+②
王晓珊，2017[9]	60/60	23/20	68/52	三阶梯止痛+华蟾素胶囊	三阶梯止痛	不详	①NRS 评分+②+③KPS 评分
杨庆伟，2021[10]	31/31	31/31	45/17	XELOX 方案化疗+华蟾素胶囊	XELOX 方案化疗	128	①VAS 评分+②+③KPS 评分
钟俐强，2019[11]	44/42	44/42	55/31	CapeOX+华蟾素胶囊案治疗	CapeOX	42	①NRS 评分+②
张益，2021[12]	50/50	15	52/48	盐酸羟考酮缓释片+华蟾素胶囊	盐酸羟考酮缓释片	14	①NRS 评分+②+③ KPS 评分、BPQ
梁会敏，2021[13]	39/39	6/5	45/33	三阶梯止痛+华蟾素胶囊	三阶梯止痛	28	①NRS 评分+②+③KPS 评分
刘云霞，2005[14]	30/30	6/5	39/21	华蟾素注射液	美施康定片	28	①VAS 评分+③KPS 评分
温洋，2018[15]	41/41	5/5	48/35	氨酚羟考酮+华蟾素注射液	氨酚羟考酮	14	①VRS+③KPS 评分
黄志有，2016[16]	45/45	4	49/41	盐酸羟考酮控释片+华蟾素胶囊	盐酸羟考酮控释片	28	①NRS 评分+②+③BPI
王济国，2016[17]	144/144	41	159/129	盐酸羟考酮控释片+华蟾素注射液	盐酸羟考酮控释片	14	①NRS 评分+②+③KPS 评分
陈振鹏，2019[18]	60/60	12	70/50	盐酸羟考酮缓释片+华蟾素片	盐酸羟考酮缓释片	28	①NRS 评分+②+③KPS 评分
王芸，2018[19]	120/120	10/9	148/92	伊班膦酸钠注射液+华蟾素注射液	伊班膦酸钠注射液	28	①《临床肿瘤内科手册》标准+②+③KPS 评分
王卫华，	30/30	不详	36/24	吗啡缓	吗啡缓	7	①NRS 评分+②+

2012[20]				释片+元胡止痛胶囊	释片		③KPS 评分
吕任齐，2001[21]	91/30	不详	不详	复方桂参止痛合剂＋强痛定模拟片	复方桂参止痛合剂模拟＋强痛定片	7	①NRS 评分+②
钟进才，2004[22]	36/33	不详	39/30	桂参止痛合剂	路盖克	7	①NRS 评分+②+③数字标尺法
陈长怀，2000[23]	204/114	不详	不详	桂参止痛合剂＋强痛定模拟片	桂参止痛合剂模拟＋强痛定片	7	①NRS 评分+②+③KPS 评分
王薇，2021[24]	50/45	8/5	63/32	草乌甲素	布洛芬缓释胶囊/曲马多缓释片	7	①NRS 评分+②+③QOL-C30
周文丽，2005[25]	48/48	8	52/44	新癀片+美施康定	美施康定	7	①VRS 评分+②
骆学新，2000[26]	92	4	66/26	新癀片	无对照	不详	①《现代肿瘤学》疼痛分级+②+③KPS
林德荣, 2014[35]	48/48	10	50/46	康莱特注射液+奥施康定	奥施康定	7	①NRS 评分+②+③BPQ
周长芳，2016[36]	60/60	8/8	68/52	康莱特注射液+吗啡类	吗啡类	42	①NRS 评分+③QOL
成建德，2009[37]	40/36	16	44/32	康莱特注射液+营养支持+三阶梯镇痛	营养支持+三阶梯镇痛	42	①VAS 评分+③KPS
李同度，1999[38]	376	28	233/143	康莱特注射液	无	20	①NRS 评分+②+③KPS\QOL-C30
杜敏，2015[39]	58/58	不详	52/64	康莱特胶囊+吗啡缓释片	吗啡缓释片	20	①VAS 评分+③SF-36
王彦宏，2015[40]	38/37	15	40/35	康莱特注射液+最佳支持治疗	最佳支持治疗	30	①WHO 实体瘤疗效诊断判断+③KPS
孙莹	30/30	30/30	31/29	康莱特	化疗	28	①VAS 评分+②+

莹，2020[41]				注射液+化疗			③KPS
缪亚军，2011[42]	34/32	34/32	38/28	康莱特注射液+化疗	化疗	112	①NRS 评分+②+③KPS
吕伟华，2016[43]	36/36	11	42/30	湿润烧伤膏	红霉素软膏	不详	①国际抗癌联盟急性放射反应诊断标准、主诉疼痛分级标准
李艳丽，2007[44]	102/102	不详	124/80	如意金黄散	硫酸镁	7	①化疗药致静脉炎分级
郝建华，2018[30]	41/41	41/41	40/42	复方苦参注射液+化疗	化疗	63	①NRS 评分+②+③BPI-QOL
温艳艳，2019[31]	32/32	32/32	35/29	复方苦参注射液+盐酸羟考酮缓释片	盐酸羟考酮缓释片	10	①NRS 评分+②+③QOL-C30
费小东，2020[32]	50/50	50/50	58/42	复方苦参注射液+盐酸羟考酮缓释片	盐酸羟考酮缓释片	10	①NRS 评分+③WHOQOL-BREF
李爽，2021[33]	30/30	30/30	29/31	艾灸配合复方苦参注射液	西药止痛	14	①NRS 评分+③QOL

①疼痛缓解率（要求有明确的疼痛评估指标及疗效评价标准）②不良反应发生率③生活质量评分

附录 3 疼痛评估方法

1.数字分级法(NRS)：使用《疼痛程度数字评估量表》（见图 1）对患者疼痛程度进行评估。将疼痛程度用 0-10 个数字依次表示，0 表示无疼痛，10 表示能够想象的最剧烈疼痛。交由患者自己选择一个最能代表自身疼痛程度的数字，或由医护人员协助患者理解后选择相应的数字描述疼痛。按照疼痛对应的数字，将疼痛程度分为：轻度疼痛（1-3），中度疼痛（4-6），重度疼痛（7-10）。

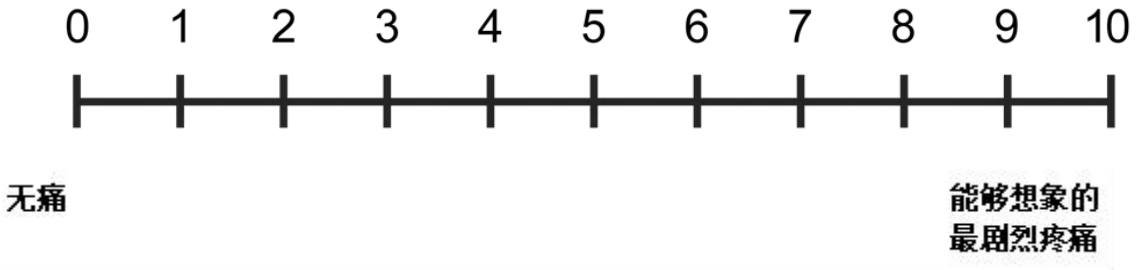


图1. 疼痛程度数字评估量表

2.面部表情疼痛评分量表法：由医护人员根据患者疼痛时的面部表情状态，对照《面

部表情疼痛评分量表》（见图 2）进行疼痛评估，适用于自己表达困难的患者，如儿童、老年人、存在语言文化差异或其他交流障碍的患者。

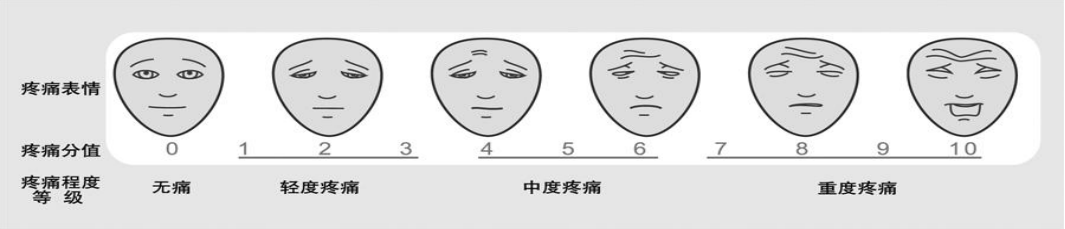


图2. 面部表情疼痛评分量表

3.主诉疼痛程度分级法(VRS)：主要是根据患者对疼痛的主诉，可将疼痛程度分为轻度、中度、重度三类。

（1）轻度疼痛：有疼痛，但可忍受，生活正常，睡眠未受到干扰。

（2）中度疼痛：疼痛明显，不能忍受，要求服用镇痛药物，睡眠受到干扰。

（3）重度疼痛：疼痛剧烈，不能忍受，需用镇痛药物，睡眠受到严重干扰，可伴有植物神经功能紊乱或被动体位。

附录 4 临床问题清单

临床问题清单

临床问题	P	I	C	O
1.中西医结合治疗结直肠癌疼痛是否优于单纯西医治疗？	结直肠癌疼痛患者	中西医结合治疗	西医治疗	降低疼痛评分、增加疼痛缓解率、降低不良反应、提高生活质量

附录5 证据分级标准

证据分级标准参考刘建平教授在《中医药循证医学》中提出的传统医学证据体的构成及证据分级的建议，本指南结合临床实际作适当修订。

Ⅰa：在随机对照试验、队列研究、病例对照研究、病例系列这四种研究中，至少 2 种不同的类型的研究构成的证据体，且不同研究结果的效应一致；实施较好的 Meta 分析或系统评价。

Ⅰb：具有足够把握度的单个随机对照试验。

Ⅱa：非随机对照研究或队列研究(有对照的前瞻性研究)。

Ⅱb：病例对照研究。

Ⅲa：历史性对照的系列病例。

Ⅲb：自身前后对照的病例系列。

Ⅳ：长期在临床上广泛运用的病例报告和史料记载的疗法；方向共识意见。

Ⅴ：未经系统研究验证的方向观点和临床经验，以及没有长期在临床上广泛运用的病例报告和史料记载的疗法。

参考文献：

[1]杨昭,张岚.芍药甘草汤加减对中晚期结肠癌癌性疼痛患者生活质量及生存率的影响.辽宁中医杂志,2020,47(1):99-104.
[2]董毅.复方斑蝥胶囊联合化疗治疗中晚期恶性肿瘤的疗效观察[J].中国肿瘤临床与康复,2012,19(04):367-368.
[3]邹方友,周莉,熊宜军.复方夏天无片治疗轻度癌痛的临床观察[J].中国现代应用药学,2011,28(03):268-270.
[4]李琦.复方夏天无片治疗癌性疼痛 30 例[J].福建中医药,2008(03):40.
[5]许晶,钱树树,陈耀国,等.华蟾素治疗癌痛有效性和安全性的系统评价和Meta 分析[J].中国中药杂志,2019,44(12):2627-2636.
[6]金金,马银杰,何生奇. 华蟾素胶囊联合化疗治疗晚期结直肠癌的系统评价与 Meta 分析.中国中医基础医学杂志, 2020 ,26(9):1312-1316.
[7]彭莹莹, 陈哲, 王方园等. 华蟾素胶囊联合奥沙利铂化疗方案治疗结直肠癌的 Meta 分析.中医学报,2020,35(262):673-678.
[8]杨宏,韩震,何敏,等.华蟾素改善结直肠癌疼痛的效果分析[J].肿瘤药学,2018,8(1):57-63.
[9]王晓珊,陈琳,何阳科,等.华蟾素胶囊对消化道恶性肿瘤疼痛的疗效观察[J].川北医学院学报,2017,32(1):71-74.
[10]杨庆伟,彭世龙. XELOX 方案联合华蟾素胶囊治疗晚期结直肠癌的临床效果及安全性.临床医学研究与实践, 2021,6 (12):36-38.
[11]钟俐强,何杰,徐艳等.华蟾素胶囊联合 CapeOX 方案治疗老年晚期结直肠癌临床观察.实用老年医学, 2019 ,33 (11):1123-1125.
[12]张益,李晓丹,万里新.华蟾素胶囊联合盐酸羟考酮缓释片治疗癌性疼痛疗效观察.国医论坛,2021,36(3):45-47.
[13]梁会敏,董艳萍,周冰.华蟾素胶囊治疗癌性疼痛的疗效观察.医药论坛杂志,2021,42(13):129-132.
[14]刘云霞,匡唐洪,蒋沈君.华蟾素注射液改善晚期癌症患者生活质量的临床观察. 中国中医药科技,2005,12(1):45-46.
[15]温洋,白东玉,吴彦岭等.华蟾素注射液联合氨酚羟考酮治疗中重度癌性内脏痛的疗效观察.临床和实验医学杂志, 2018, 17(7):731-733.
[16]黄志有,黄兆明,陶玉等.羟考酮缓释片联合华蟾素胶囊对恶性肿瘤骨转移疼痛患者生活质量的影响.浙江中西医结合杂志,2016,26(10):918-920.
[17]王济国,简文静,李阳.羟考酮缓释片与华蟾素注射液用于中重度癌痛患者的疗效比较.中国实用医药,2016,11(17):139-140.
[18]陈振鹏,李克华.盐酸羟考酮缓释片联合华蟾素治疗癌痛的效果分析.中国社区医师,2019,35(8):130-131.
[19]王芸,李应宏,张宇杰等.伊班膦酸钠注射液联合华蟾素注射液治疗骨转移癌痛患者临床观察. 内科,2018,13(2): 170-173.
[20]王卫华,周小伟.活血行气化瘀法治疗癌性疼痛疗效分析.山东中医杂志,2012, 31(10):725-727.
[21]吕任齐,张灿珍.桂参止痛合剂对癌痛的双盲双模拟临床试验[J].云南中医中药杂志,2001,22(01):5-6.

[22]钟进才,阙铁生,张华萍,等.桂参止痛合剂治疗中重度晚期癌症疼痛的临床评价[J].中国疼痛医学杂志,2004,10(02):88-91.
[23]陈长怀,孙桂芝,唐文秀,等.桂参止痛合剂治疗癌性疼痛临床观察[J].中国新药杂志,2000,9(03):196-200.
[24]王薇,李杰,刘航,等.草乌甲素片治疗轻中度癌痛多中心、随机对照、非劣效性研究[J].中国疼痛医学杂志,2021,27(3):188-195.
[25]周文丽,考军,宋浩.新癀片配合美施康啶治疗重度癌痛增效减毒临床观察[J].中国中医急症,2005,14(12):1172-1173.
[26]骆学新,张著,陶寿文.新痛片治疗癌痛92例临床观察.中国中西医结合杂志,2000,20(3):232-233.
[27]李德辉,孙春霞,范焕芳.复方苦参注射液联合盐酸羟考酮缓释片治疗癌痛的系统评价.中国疼痛医学杂志[J], 2017, 23 (5):384-388.
[28]黄奕雪,郭玉明,桑秀秀,等.复方苦参注射液治疗癌性疼痛的系统评价.中国实验方剂学杂志[J],2016,22(2):172-179.
[29] 陈芝强,李泽云,李菁等.复方苦参注射液联合唑来膦酸治疗骨性癌痛的 Meta 分析.中医肿瘤学杂志,试刊号:79-85.
[30]郝建华.复方苦参注射液联合化疗治疗结直肠癌骨转移疼痛的临床观察[J].天津药学,2018,30(1):59-61.
[31]温艳艳.复方苦参注射液联合奥施康定治疗中晚期肠癌癌性疼痛患者的效果.中国民康医学,2019,31(21):89-90.
[32]费小东.复方苦参注射液联合奥施康定治疗中晚期肠癌癌性疼痛的临床疗效.系统医学,2020,5 (22):121-123.
[33]李爽,李晶,薛晴等.艾灸配合复方苦参注射液对直肠癌晚期患者癌性疼痛的临床研究.黑龙江医药科学,2021,44(3):45-47.
[34]廖剑锋,林纯旋,李正发等.康莱特联合化疗与单纯化疗治疗结直肠癌的 meta 分析.中国卫生统计,2017,34(4):620-624.
[35]林德荣.奥施康定联合康莱特注射液治疗中晚期癌痛的疗效观察.浙江临床医学,2014,16(6):941-942.
[36]周长芳,温林春,唐红兰.康莱特改善晚期恶性肿瘤患者生活质量的作用.包头医学院学报,2016,32(4):82-84.
[37]成建德.康莱特注射液为主提高晚期癌症患者 生存质量临床观察.山西中医,2009,25(7):29-30.
[38]李同度,刘爱国,秦叔逵等.康莱特注射液控制癌痛 及提高晚期癌症患者生存质量Ⅲ期临床研究.中国肿瘤临床,1999,26(5):372-376.
[39]杜敏.康莱特联合吗啡缓释片对重度癌性疼痛患者止痛及生活质量的影响.按摩与康复医学,2015,6(16):33-34.
[40]王彦宏.最佳支持治疗联合康莱特治疗老年晚期消化道肿瘤的疗效.中国老年保健医学,2015,13(2):81-82.
[41]孙莹莹,梁莹,叶广铎.康莱特注射液联合 FOLFOX4 方案治疗晚期结直肠癌.西部医学,2020,32(8):1184-1188.
[42]缪亚军, 王亚非.康莱特注射液联合化疗治疗结直肠癌肝转移的临床观察.中华肿瘤防治杂志, 2011,18 (9):726-727.
[43]吕伟华,徐秀梅.湿润烧伤膏治疗放射性皮炎的临床观察.中国医药导刊,2016,18(8):822-823.
[44]李艳丽,赵振英,胡春华.醋调如意金黄散加冰敷治疗化疗药所致非外渗性静脉炎疗效观察.中国煤炭工业医学杂志,2007,10(6):651-652.
[45]于世英,王杰军,王金万等.晚期癌症患者合并肠梗阻治疗的专家共识.中华肿瘤杂志,2007,29(8):637-640.
[46]郭鹏,杨金坤.结直肠恶性肿瘤梗阻的中医治疗现状.中医药学刊,2006,24(7):1292-1295.
[47]杨士民,项琦,常艳等.复方大承气汤联合肠梗阻导管治疗恶性肠梗阻的临床研究.中国中西医结合外科杂志, 2021,27 (1):14-19.

[48]宋媛媛,常靖,许鹏.麻子仁汤加减治疗恶性肠梗阻临床研究.中医学报,2016,31(10):1145-1148.
[49]程钰,王芳,朱世杰等.中医外治法在恶性肠梗阻治疗中的研究进展.河南中医,2019,39(10):1608-1611.
[50]王影利,袁东海.复方大承气汤配方颗粒加减应用治疗恶性肠梗阻临床观察.2015,27(5):702-704.
[51]姜敏,左明焕,刘传波等.中药灌肠治疗恶性肠梗阻 106 例临床观察.辽宁中医杂志,2009,36(10):1729-1730.
[52]左文超,曹芳,刘健.中药外敷脐贴辅助治疗恶性肠梗阻的临床观察.World Latest Medicine Information (Electronic Version), 2017,17(58):160.
[53]张勇.中药通腑理气方灌肠联合针灸治疗癌性肠梗阻.光明中医,2012 ,27 (10):2151-2152.
[54]袁庆延,丁曙晴.中医药防治放射性肠炎研究进展.世界中医药,2016 ,11(11):2490-2494.
[55]兰平,马腾辉.中国放射性直肠损伤多学科诊治专家共识（2021 版）.中华胃肠外科杂志 2021, 24(11):937-949.
[56]唐幸林子,方灿途,孟金成等.放射性肠炎的中医治疗研究进展.广州中医药大学学报,2019, 36(3):443-446.
[57]任建平,孙光军.放射性直肠炎中医药研究新进展.中西医结合研究,2013,5(2):99-101.
[58]魏开建.葛根芩连汤治疗放射性肠炎的临床疗效观察.福建中医学院学报,2009,19(6):13-14.
[59]连雅君,吴梦瑶,赵德智等.中药灌肠治疗放射性肠炎的系统评价.世界中医药,2021,16(16):2435-2444.
[60]张东伟,祝永福,王曙光等.十灰散保留灌肠治疗急性放射性肠炎的临床研究.光明中医,2014,29(7):1410-1412.